

Hemorragia digestiva alta y baja

1. Introducción y relevancia clínica

La **hemorragia digestiva** corresponde a la **pérdida de sangre desde cualquier punto del tubo digestivo**, desde el esófago hasta el recto.

Se clasifica según el nivel anatómico del sangrado en:

- **Hemorragia Digestiva Alta (HDA):** proximal al ligamento de Treitz (esófago, estómago, duodeno).
- **Hemorragia Digestiva Baja (HDB):** distal al ligamento de Treitz (yeyuno, íleon, colon, recto).

Importancia clínica

- Es una **emergencia médica y quirúrgica**.
- Requiere manejo rápido para evitar shock hipovolémico.
- En Chile, la causa más frecuente de HDA sigue siendo la **úlcera péptica**, mientras que la **HDB** se debe habitualmente a **diverticulosis colónica**.

Mortalidad global:

- HDA: 5–10%.
 - HDB: 2–5%, aunque aumenta con edad avanzada y comorbilidades.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Hemorragia digestiva alta

El sangrado se origina por **lesión de vasos en la mucosa gastroduodenal o esofágica**, debido a:

- Erosión mucosa (AINE, ácido gástrico).

- Ruptura vascular (várices esofágicas, lesión de Dieulafoy).
- Laceración (Mallory-Weiss).

2.2 Hemorragia digestiva baja

Resulta de **lesiones en colon o recto**, por fragilidad vascular, inflamación o neoplasia.

La pérdida de sangre puede ser intermitente o masiva.

2.3 Fisiopatología general

1. **Pérdida aguda de sangre** → **hipovolemia** → **disminución del gasto cardíaco**.
2. **Compensación hemodinámica**: vasoconstricción esplácnica, taquicardia.
3. Si el sangrado persiste → **shock hipovolémico y acidosis láctica**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones generales

- Mareos, palidez, taquicardia, hipotensión.
- **Síntomas de hipovolemia**: frialdad, diaforesis, colapso.
- **Signos de anemia**: disnea, fatiga, astenia.

3.2 Hemorragia digestiva alta

Síntomas característicos

- **Hematemesis**: vómito de sangre roja o en “posos de café”.
- **Melena**: deposiciones negras, alquitranadas, malolientes (≥ 50 mL de sangre digerida).
- **Hematoquezia**: si el sangrado es masivo y rápido.

Causas más frecuentes

Etiología	Características clínicas
Úlcera péptica (duodenal o gástrica)	Más frecuente; asociada a AINEs o H. pylori
Gastritis erosiva	Múltiples erosiones superficiales; frecuente en críticos
Várices esofágicas	Historia de cirrosis; hematemesis masiva
Desgarro de Mallory-Weiss	Hematemesis tras vómitos repetidos; alcohólicos
Lesión de Dieulafoy	Arteriola submucosa sangrante, sin úlcera aparente

3.3 Hemorragia digestiva baja

Síntomas característicos

- **Hematoquezia:** sangre roja brillante o vino tinto en heces.
- **Melena (raro):** si sangrado alto y lento.
- **Ausencia de dolor** en la mayoría de los casos.

Causas más frecuentes

Etiología	Descripción
Diverticulosis colónica	Sangrado indoloro, masivo y autolimitado
Angiodisplasia	Pacientes añosos, sangrado intermitente

Cáncer colorrectal	Sangrado crónico, anemia ferropénica
---------------------------	--------------------------------------

Colitis isquémica o infecciosa	Dolor + diarrea con sangre
---------------------------------------	----------------------------

Hemorroides / fisuras anales	Sangre roja en papel o goteo postdefecación
-------------------------------------	---

3.4 Diagnóstico diferencial de hematemesis / rectorragia

Síntoma	Diagnóstico diferencial principal
Hematemesis	Úlcera péptica, várices esofágicas, Mallory-Weiss
Melena	HDA o hemorragia de intestino delgado
Rectorragia	HDB, pero también puede ser HDA masiva
Sangre oculta en deposiciones	Cáncer colorrectal o pólipos

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial

- **Signos vitales y estabilidad hemodinámica.**
- **Hemograma completo:** hemoglobina puede ser normal inicialmente.

- **Pruebas de coagulación (TP, INR, TTPa).**
 - **Función renal y electrolitos (urea ↑ en HDA).**
 - **Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas.**
 - **Gasometría arterial:** evalúa acidosis y perfusión tisular.
-

4.2 Exámenes específicos

A. Hemorragia digestiva alta

- **Endoscopía digestiva alta (EDA):**
 - *Gold standard diagnóstico y terapéutico.*
 - Debe realizarse dentro de las primeras **12–24 h** del ingreso.
 - Identifica la fuente y permite tratamiento endoscópico (adrenalina, clips, coagulación).
- **Clasificación de Forrest (para úlcera péptica):**

Tipo Forrest	Hallazgo endoscópico	Riesgo de resangrado
Ia	Sangrado en chorro	90%
Ib	Sangrado babeante	60%
IIa	Vaso visible	40%
IIb	Coágulo adherido	25%
IIc	Mancha pigmentada	10%

III Base limpia <5%

Forrest I y IIa–IIb requieren tratamiento endoscópico inmediato.

B. Hemorragia digestiva baja

- **Colonoscopia total:**
 - Examen diagnóstico de elección (sensibilidad 70–90%).
 - Debe realizarse una vez estabilizado el paciente.
 - Permite hemostasia endoscópica.
 - **Angio-TAC o angiografía mesentérica:**
 - En sangrado activo >0,5 mL/min.
 - Permite localización y eventual embolización.
 - **Cintigrafía con glóbulos rojos marcados:** útil en sangrado intermitente.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / ACG / WSES)

5.1 Medidas iniciales

1. **Reanimación hemodinámica inmediata:**
 - Vía venosa gruesa x2.
 - Cristaloideos isotónicos (suero fisiológico o Ringer lactato).
 - Transfusión de glóbulos rojos si Hb <7 g/dL (o <9 g/dL en cardiopatía).
 2. **Monitorización continua.**
 3. **Suspender AINES, anticoagulantes y antiagregantes (según riesgo).**
-

5.2 Tratamiento específico

A. Hemorragia digestiva alta

1. Farmacológico

- **IBP endovenoso:** omeprazol o pantoprazol bolo + infusión continua (80 mg EV, luego 8 mg/h por 72 h).
- **Erradicación de *H. pylori*** en caso de úlcera.
- **Várices esofágicas:**
 - Terlipresina 2 mg EV c/4h o somatostatina.
 - Profilaxis antibiótica (ceftriaxona 1 g/día EV).
 - Ligadura endoscópica o escleroterapia.
 - Si falla → *TIPS (derivación portosistémica)*.

2. Endoscópico

- Inyección de adrenalina 1:10.000.
- Coagulación térmica o con argón plasma.
- Clips hemostáticos.

3. Quirúrgico

- Indicación: sangrado no controlado o recidiva masiva.
- Procedimientos:
 - *Ulcerorrafia con epiploplastia* (úlcera duodenal).
 - *Gastrectomía parcial* (úlcera gástrica o tumor).
 - *Derivación portosistémica quirúrgica* (várices refractarias).

B. Hemorragia digestiva baja

1. Medidas iniciales

- Igual protocolo de reanimación.
- Sonda nasogástrica si duda de origen alto.

2. Tratamiento según causa

Etiología	Tratamiento
Diverticulosis	Colonoscopia con clip o coagulación; embolización si persiste
Angiodisplasia	Coagulación endoscópica; embolización selectiva
Cáncer colorrectal	Cirugía oncológica
Colitis isquémica o infecciosa	Tratamiento médico; cirugía si necrosis
Hemorroides	Ligadura o hemorroidectomía selectiva

3. Cirugía

- Indicación: sangrado persistente o recidivante grave.
- Tipo: **colectomía segmentaria o subtotal**, según localización.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Shock hipovolémico	Pérdida >30% de volemia, requiere manejo en UCI

Síndrome de resangrado 10–20% de casos pese a tratamiento endoscópico

Perforación Complicación endoscópica

Insuficiencia renal aguda Por hipoperfusión

Muerte Asociada a edad, comorbilidades, retardo diagnóstico

Pronóstico:

- Mortalidad HDA: 5–10%.
- Mortalidad HDB: <5%, pero puede alcanzar 20% en mayores de 80 años.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Melena** → **siempre pensar en hemorragia digestiva alta.**
 2. **Endoscopia temprana (≤ 24 h)** es tanto diagnóstica como terapéutica.
 3. **IBP EV antes de endoscopia** mejora la estabilidad hemostática.
 4. **Várices esofágicas:** terlipresina + ceftriaxona + ligadura endoscópica.
 5. **Colonoscopia** es el método diagnóstico de elección en HDB estable.
 6. **Transfusión restrictiva** (Hb <7 g/dL) mejora pronóstico.
 7. **Sonda nasogástrica con aspirado hemático** confirma origen alto.
-



Errores comunes

- Retrasar la reanimación mientras se espera la endoscopia.
 - No suspender AINES o anticoagulantes.
 - Usar antagonistas H2 en lugar de IBP EV.
 - No repetir endoscopia tras resangrado.
 - Realizar colonoscopia sin estabilización previa.
 - Omitir profilaxis antibiótica en várices esofágicas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hematemesis o melena = hemorragia digestiva alta; hematoquezia = baja.**
2. **Endoscopia** es el examen de elección en ambos tipos, con capacidad terapéutica.
3. **Úlcera péptica** es la causa más frecuente de HDA; **diverticulosis** en HDB.
4. **IBP EV y erradicación de H. pylori** son esenciales en úlcera sangrante.
5. **Terlipresina + ceftriaxona + ligadura** en várices esofágicas.
6. **Reanimación precoz y transfusión prudente** mejoran la sobrevida.
7. **El 80–90% de los casos se resuelven sin cirugía, pero el tiempo es vital.**